SMILE WELL DENTAL GROUP
Professional Dental Care | Coquitlam & Langley, BC

HPOA 준수
2026년 4월 1일 시행

치아 교정 치료 동의서

고정식 교정장치 (브라켓) 및 투명교정장치 (인비절라인 등)

교정 장치 종류 (해당 항목 표시)

☐ 메탈 고정식 장치 (일반 브라켓 및 와이어)

☐ 세라믹 / 치아색 고정식 장치 (투명 브라켓)

☐ 설측 고정식 장치 (치아 안쪽 부착)

☐ 투명교정장치 — Invisalign® ☐ 투명교정장치 — 기타 브랜드: _____

☐ 부분 교정 (앞니 부분만) ☐ 전악 교정 (전체 치아)

☐ 1기 치료 (혼합치열기 조기 교정) ☐ 2기 치료 (영구치 완성 후 교정)

교정 치료 허가

진단 기록(사진, 방사선 사진, 디지털 스캔 또는 인상, 임상 검사)을 바탕으로 수립된 치료 계획에 따라 담당 의사가 본인(또는 법정 대리인인 환자)에게 교정 치료를 제공하도록 허가합니다. 치료 진행 중 생물학적 반응, 성장 양상, 예기치 못한 임상 소견에 따라 계획 수정이 필요할 수 있음을 이해하며, 담당 의사가 최선의 임상적 판단에 따라 합리적 범위 내에서 시술을 조정하도록 허가합니다. 중대한 변경 사항은 반드시 본인과 상의됩니다.

교정 치료의 성격

교정 치료는 부정 배열된 치아와 턱, 부정 교합의 진단·예방·교정을 담당하는 치과 분야입니다. 치료에는 교정 장치 — 고정식 장치(치아에 부착된 브라켓을 와이어로 연결), 또는 가철성 투명교정장치(환자 맞춤형 투명 플라스틱 트레이를 순차적으로 착용) — 가 사용되며, 지속적이고 부드러운 힘을 가해 치아를 서서히 바람직한 위치로 이동시킵니다.

능동적 교정 치료는 사례의 복잡성, 선택한 장치, 환자의 생물학적 반응, 협조도에 따라 일반적으로 12~36개월 소요됩니다. 능동 치료 이후에는 치아 위치 재발을 막기 위해 평생에 걸친 유지 단계가 반드시 필요합니다.

교정 결과는 환자의 협조, 구강 위생, 성장(청소년), 개인 생물학적 반응에 크게 좌우됩니다. 따라서

특정한 결과, 편안함 수준, 치료 기간은 보장되지 않습니다.

1기 치료 (조기 개입) 및 2기 치료 (포괄 치료) — 성장기 환자

1기 치료(조기 개입)는 유치열 또는 혼합치열기(일반적으로 6~10세)에 아동이 아직 성장 중일 때 시행하는 조기 교정 개입입니다. 목표는 제한적이고 특정적이며, 이후에 효과적으로 관리하기 어려운 특정 발육 문제를 교정하는 것입니다. 여기에는 전치부 또는 구치부 교차교합, 심한 총생, 외상 위험이 있는 상악 전치의 돌출, 구강 습관(손가락 빨기, 혀 내밀기), 성장 유도가 필요한 골격성 턱 부조화, 유치 조기 상실로 인한 공간 손실 등이 포함됩니다. 1기 치료에는 구개 확장 장치, 부분 브라켓, 기능성 장치, 공간유지장치 등이 사용되며, 치료 기간은 일반적으로 6~18개월이고 이후 모든 영구치가 맹출할 때까지 관찰합니다.

1기 치료는 2기 치료를 대체하지 않습니다. 대부분의 1기 치료 환자는 모든 영구치가 맹출된 후(일반적으로 11~14세) 고정식 장치 또는 투명교정장치를 이용한 2기(포괄) 치료가 추가로 필요합니다. **1기 치료와 2기 치료는 별도의 치료이며 각각 별도의 치료 계획·장치·기간·비용이 적용됩니다 — 1기 치료비는 2기 치료비를 포함하지 않습니다.** 1기 치료는 2기 치료의 복잡성, 기간, 발치/수술 필요성을 줄일 수 있으나, 이러한 결과는 보장되지 않습니다.

장치 선택: 고정식 장치(브라켓) vs 투명교정장치

아래 비교는 두 가지 주요 교정 장치의 핵심 차이를 요약합니다. 담당 의사가 환자의 사례에 가장 적합한 장치를 상담합니다.

고정식 교정장치 (브라켓)	투명교정장치 (인비절라인)
설명 치아에 부착하는 메탈 또는 세라믹 브라켓을 와이어로 연결하며, 4~8주마다 내원하여 와이어 조정을 시행합니다. 치료 중 환자가 임의로 제거할 수 없습니다.	**설명** 환자 맞춤 제작된 가철성 투명 플라스틱 트레이를 순차 착용 (각 트레이 1~2주). 하루 20~22시간 착용 필수. 특정 움직임을 위해 치아색 컴포지트 어태치먼트(돌출부) 부착이 일반적으로 필요합니다.
장점 • 모든 종류의 부정교합(중증 포함)에 효과적 • 환자 협조 불필요 (착용 시간 준수 불필요) • 개별 치아 이동에 대한 정밀 조절 가능 • 복잡한 사례의 경우 치료 기간이 더 짧을 수 있음	**장점** • 거의 보이지 않음 — 심미성 탁월 • 가철식 — 구강위생 관리 쉽고 음식 제한 없음 • 장치 파손으로 인한 응급 내원 없음 • 편안함 (매끈한 플라스틱, 와이어 없음)

- 일반적으로 총 비용이 저렴
- 어린이를 포함한 전 연령대 가능

단점 / 한계

- 치아에 장치가 보임 (세라믹 브라켓도 완전 투명 아님)
- 구강위생 불량 시 탈회 및 백반증 위험이 훨씬 높음
- 음식 제한 — 딱딱하거나 끈적이거나 질긴 음식 금지
- 브라켓 및 와이어로 인한 연조직 자극 가능
- 응급 내원 가능성 (브라켓 탈락, 와이어 찌름)
- 더 잦은 내원 필요

적응증

중증 부정교합, 큰 회전이 필요한 치아, 매복치, 수직적 치아 이동, 골격성 부조화, 가철성 장치 협조 불가능한 환자.

- 내원 횟수 적음

단점 / 한계

- 협조도가 결정적 — 하루 20~22시간 착용 필수. 미준수 시 치료 실패
- 어태치먼트(컴포지트 돌출부) 부착 필수이며 눈에 보임
- 치간삭제(IPR)가 자주 필요 — 비가역적 시술
- 리파인먼트(추가 트레이) 흔함 — 치료 기간 연장 가능
- 분실·파손 시 재제작 비용은 환자 부담
- 착용 중 색소 음료 섭취 시 착색 가능
- 적응기 발음 변화(혀짤배기)
- 일반적으로 고정식 대비 총 비용이 더 높음

적응증

경도~중등도 부정교합, 협조도가 매우 좋은 성인 및 청소년, 구강위생이 양호하고 심미적 요구가 있는 환자.

권장되지 않는 경우 (금기)

- 악교정수술이 필요한 중증 골격성 부정교합
- 8mm 이상의 심한 총생 또는 20° 이상의 심한 회전
- 심한 과개교합, 개방교합, 견인이 필요한 매복치
- 하루 20~22시간 착용을 준수할 수 없는 환자
- 유치 또는 혼합치열기의 어린 아동 (대부분의 경우)

위험 및 합병증 — 모든 장치 공통

다음 위험은 모든 종류의 교정 치료에 해당되며, 일부는 치아 이동에 본질적으로 수반되어 의사의 술기나 사용 장치에 관계없이 완전히 제거할 수 없음을 이해합니다:

1. **치근 흡수 (뿌리 짧아짐):** 교정력으로 치아를 이동하면 치근이 다소 짧아질 수 있습니다. 대부분은 임상적으로 의미 없는 경미한 흡수이나, 드물게 심각한 흡수가 치아의 장기 예후를 위협할 수 있습니다. 짧은 치근, 치아 외상 이력, 개인 소인이 있는 환자에서 위험이 높으며 사전 예측이 어렵습니다.
2. **탈회 및 백반증(White Spot):** 치료 중 구강위생 불량 시 법랑질에 영구적 손상(분필색 반점 또는 충치)이 발생할 수 있습니다. 고정식 장치에서 위험이 훨씬 높으나 투명교정장치에서도 발생 가능합니다. 손상은 영구적이며 수복 치료가 필요할 수 있습니다. 예방은 환자의 책임입니다.
3. **잇몸 퇴축 및 치주 문제:** 치아 이동 시, 특히 얇은 잇몸 조직이나 골 지지가 부족한 부위에서 잇몸

퇴축이나 골 소실이 발생할 수 있으며, 잇몸 이식술이 필요할 수 있습니다.

4. **치아 동요 및 치수 괴사:** 능동 이동 중 일부 치아 흔들림은 정상적입니다. 드물게 치아가 생활력을 상실하여 신경치료가 필요할 수 있으며, 이는 외상 이력이나 대규모 수복이 있는 치아에서 더 흔합니다.
5. **턱관절(TMJ) 증상:** 교정 치료는 기존 TMJ 장애를 유발·악화·현시화할 수 있습니다. 기존 TMJ 문제는 치료 옵션을 제한할 수 있습니다.
6. **치아 골유착 (Ankylosis):** 매우 드물게 치아가 골에 직접 융합되어 교정력으로 움직이지 않을 수 있습니다. 이 경우 대체 접근이 필요하거나 해당 치아를 현 위치에 두어야 할 수 있습니다.
7. **알레르기 반응:** 드물게 니켈(일부 금속 합금), 라텍스, 플라스틱, 치과용 접착제에 대한 알레르기가 발생할 수 있습니다. 모든 알려진 알레르기는 반드시 고지해야 합니다.
8. **치료 기간:** 예상 치료 기간은 평균 사례 기준의 예상치입니다. 실제 기간은 생물학적 반응, 미협조, 예약 불이행, 장치 파손, 불리한 성장, 예기치 못한 소견으로 인해 더 길어질 수 있습니다. 원래 예상 기간을 초과할 경우 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
9. **불리한 성장 (성장기 환자):** 어린이 및 청소년에서 턱뼈 성장이 불리하게 진행되면 치료 계획 변경, 추가 장치, 헤드기어, 고무줄 사용, 심한 경우 악교정수술이 필요할 수 있습니다.
10. **재발 (치료 후 치아 이동):** 평생 유지장치 착용 없이는 치아가 원위치로 되돌아갑니다. 유지장치를 착용하더라도 노화, 후기 하악 성장, 치아 마모, 연조직 리모델링으로 인한 경미한 변화는 발생할 수 있습니다. 재발에 따른 재치료는 최초 치료비에 포함되지 않습니다.
11. **발치 필요성:** 일부 사례에서 공간 확보나 적절한 결과를 위해 영구치(소구치, 사랑니 등) 발치가 필요합니다. 치료 중 발치 필요성이 새로 확인될 수 있습니다.
12. **악교정수술 필요성:** 심한 골격성 부조화가 있는 사례는 최적 결과를 위해 악교정수술이 필요할 수 있습니다. 환자가 수술을 거부하는 경우 타협된 결과(위장 치료)로 진행되며, 이로 인한 결과의 한계는 담당 의사의 책임이 아닙니다.
13. **연조직 외상:** 장치로 인한 볼·입술·혀의 일시적 자극, 궤양, 외상이 발생할 수 있습니다.
14. **완벽하지 않은 최종 결과:** 교정 치료의 목표는 완벽이 아니라 의미 있는 개선입니다. 생물학적 변이와 해부학적 한계로 인해 임상적으로 허용 가능한 범위 내에서 미세한 불일치가 남을 수 있습니다. 최종 결과는 제시된 디지털 시뮬레이션이나 ClinCheck® 미리보기와 다를 수 있으며, 이는 계획 도구이지 보장이 아닙니다.
15. **수복 치료의 필요성:** 교정 치료 후 최적의 최종 심미를 위해 추가 치과 치료(충전, 크라운, 라미네이트, 본딩, 잇몸 성형)가 필요하거나 권장될 수 있습니다. 이는 별도 진료이며 추가 비용이 발생합니다.

위 목록은 모든 위험을 망라한 것이 아니며, 다른 드문 합병증이 발생할 수 있습니다. 이러한 위험에 대해 질문할 기회를 가졌습니다.

장치별 추가 위험

고정식 장치 (해당 시)	투명교정장치 (해당 시)
• 영구적 법랑질 손상·탈회·백반증의 위험이 더 높음 • 브라켓 파손 또는 탈락으로 응급 수복 내원 필요 (비용 발생 가능) • 와이어 끝이 튀어나와 연조직 외상 유발 가능 • 제한 음식(단단함·끈적함·질김) 섭취로 인한 장치 파손은 환자 책임 • 치료 종료 시 브라켓 제거 과정에서 미세한 법랑질 손상 가능 • 세라믹(심미) 브라켓의 경우 착색·변색 가능 • 설측 장치: 적응기 혀 자극 및 발음 변화	• 하루 20~22시간 미착용 시 치료 실패. 미협조는 투명교정 실패의 가장 흔한 원인이며 환자 책임 • 컴포지트 어태치먼트를 치아에 부착해야 하며 눈에 보임 • 치간삭제(IPR) — 치아 접촉면의 소량 삭제 — 필요할 수 있으며 비가역적 시술 • 리파인먼트 트레이(계획 초과분)는 흔하며 치료 기간이 연장될 수 있음. 포함 범위 초과 시 추가 비용 발생 가능 • 최종 결과는 ClinCheck®/디지털 시뮬레이션과 다를 수 있음 — 시뮬레이션은 계획이지 보장이 아님 • 분실·파손·손상된 장치의 재제작 비용은 환자 부담 • 적응기 일시적 발음 변화, 침 증가, 구강 건조 • 착용 중 색소 음료 섭취 시 장치 및 어태치먼트 착색 • 세척 불량 시 냄새·착색·세균 증식 발생 가능

필요할 수 있는 추가 시술

치료 중 또는 시작 전에 다음과 같은 추가 시술이 권장되거나 필요할 수 있습니다. 서면 치료 계획서에 명시된 경우를 제외하고 각 시술은 별도 비용이 발생합니다:

- 발치 (소구치, 사랑니 등)
- 치간삭제 (IPR — 치아 접촉면 소량 삭제)
- 컴포지트 어태치먼트 부착 (투명교정용)
- 미니 임플란트 / 교정용 임시 고정원 (TAD)
- 고무줄 (환자가 매일 직접 착용)
- 헤드기어 또는 기타 구외 장치 (소아 환자)
- 구개 확장 장치 (고정식 또는 가철식)
- 악교정수술 (중증 골격성 사례)
- 치주 잇몸 이식술 또는 기타 잇몸·골 치료
- 설소대·상순소대 절제술
- 교정 전·중·후 수복 치료 (충전, 크라운, 라미네이트, 본딩)
- 신경치료 (치수 괴사 발생 시)

- 유지장치 재제작 (초기 제공분 이후)

유지 (Retention) — 평생 필수 사항

교정 치료 후 유지에 관하여 다음 사항을 이해하고 동의합니다:

- 치아는 교정 치료 후 원래 위치로 되돌아가려는 자연적 경향이 있으며, 이를 재발(Relapse) 이라 합니다.
- 유지장치 착용은 평생 필요하며, 선택 사항이 아닙니다.
- 일반적 유지 프로토콜: 장치 제거 후 처음 3~6개월은 종일 착용, 이후에는 무기한 야간 착용 (매일 밤, 평생).
- 유지장치 종류: 가철성(Hawley 또는 투명 Essix 타입) 및/또는 고정식(앞니 설측에 부착된 얇은 와이어). 담당 의사가 적절한 종류를 권장합니다.
- 지시대로 유지장치를 착용하지 않으면 치아가 이동하여 재발이 발생합니다. 이는 가장 흔한 "교정 재발" 원인이며 환자 책임입니다.
- 유지장치는 분실·파손되거나 시간이 지남에 따라 닳을 수 있습니다. 재제작 비용은 별도이며 최초 치료비에 포함되지 않습니다.
- 유지장치를 완벽히 착용하더라도 정상적 노화, 지속되는 성장, 치아 마모, 연조직 리모델링으로 인해 수년에 걸쳐 경미한 변화가 있을 수 있습니다. 이는 치료 실패가 아닙니다.
- 하악 앞니의 후기 총생은 정상적 노화 현상이며, 특히 하악 유지장치를 중단하는 경우 양호한 유지에도 불구하고 발생할 수 있습니다.
- 유지장치 미착용으로 인한 재발에 대한 재치료는 최초 교정비에 포함되지 않습니다.

환자 협조 및 책임

교정 치료의 성공은 본인의 완전한 협조에 크게 좌우됨을 이해하며 다음을 약속합니다:

- 예정된 모든 내원 약속 참석 (고정식은 일반적으로 4~8주마다, 투명교정은 8~12주마다).
- 치료 기간 내내 우수한 구강 위생 유지 (칫솔질, 치실, 치간칫솔/워터픽, 권장된 불소 사용).
- 교정 치료 중에도 주치의와의 정기 검진 및 스케일링 지속.
- 모든 음식 제한 사항 준수 (고정식: 딱딱하거나 끈적이거나 질긴 음식 금지; 투명교정: 착용 중에는 맹물 외 음료 섭취 및 식사 금지).
- 투명교정 선택 시 하루 20~22시간 착용 필수.
- 고무줄, 헤드기어, 보조 장치를 지시대로 정확히 착용.
- 장치를 조심스럽게 관리하고 파손 유발 행동 금지 (단단한 물체 씹기, 장치 조작 등).

- 응급 상황(브라켓 파손, 와이어 찌름, 장치 분실, 심한 통증, 외상) 발생 시 즉시 클리닉 연락.
- 능동 치료 종료 후 지시대로 유지장치를 평생 착용.
- 분실·파손·손상된 장치 및 유지장치의 재제작 비용 부담.
- 알레르기, 복용 약물, 관련 건강 상태를 포함한 완전하고 정확한 병력 제공 및 변경사항 갱신.

미협조 시 발생 가능한 결과:

- 치료 기간 연장 (추가 비용 발생 가능)
- 타협된/불만족스러운 최종 결과
- 완전한 교정 없이 능동 치료 조기 종료
- 중증의 경우 치료 중단 및 제한적/환불 불가

교정 치료의 대안

제안된 교정 치료의 다음 대안에 대해 안내받았습니다:

- 치료하지 않음 — 현재 치아 및 턱 위치를 수용. 미교정 부정교합은 지속적 치아 마모, 구강위생 곤란, 충치·잇몸 질환 위험 증가, 턱관절 증상, 발음 문제, 심미적 문제로 이어질 수 있음을 이해합니다.
- 심미적 수복 접근만 (라미네이트, 크라운, 본딩) — 심미 문제만 해결하며, 근본적인 교합·기능·건강 문제를 교정하지 않습니다.
- 악교정수술 단독 — 교정 없이 시행되는 경우는 매우 드뭅니다.
- 본 클리닉에서 제공하지 않는 타 교정 시스템 (요청 시 의뢰 가능).
- 교정 전문의(교정학 전공 2~3년의 공인 수련을 추가로 이수한 치과의사)로의 의뢰 — 요청 시 가능하며, 특히 복잡한 골격성·수술적·소아 교정 사례에서 권장됩니다.

각 대안의 위험, 이점, 대략적 비용, 적응증에 대해 상의하였으며, 위에 표시된 교정 치료를 선택합니다.

현실적 기대치

다음 사항을 이해하고 수용합니다:

- 예상 치료 기간은 예상치이며 보장이 아닙니다.
- 교정 치료의 목표는 완벽이 아니라 치아 위치·기능·심미의 의미 있는 개선입니다.
- 치료 종료 시 임상적으로 허용 가능한 범위 내에서 미세한 불일치가 남을 수 있습니다.
- 제시된 디지털 시뮬레이션, 3D 미리보기, ClinCheck®는 계획 도구이며 최종 결과를 보장하지 않습니다.
- 리파인먼트(추가 트레이)와 치료 연장은 흔하며 치료 실패가 아닙니다.

- 특정 결과, 편안함 수준, 치료 기간은 개인 생물학·협조·협력에 크게 좌우되므로 보장될 수 없습니다.

재정적 책임

- 교정 치료비는 서면 재정 계약서에 명시된 능동 치료 단계를 포함하며, 일반적으로 계획된 내원 횟수, 최초 트레이 또는 장치 시리즈, 초기 유지장치 세트를 포함합니다.
- 원래 예상을 초과하는 치료 연장, 계획된 범위를 초과하는 추가 리파인먼트 트레이, 분실/파손 장치 및 유지장치 재제작, 추가 시술(발치, 수술, 수복, 치주 치료, TAD), 재발에 대한 재치료는 별도 진료이며 추가 비용이 발생합니다.
- 능동 치료 시작(장치 부착 또는 첫 트레이 전달) 이후 치료비는 대부분 환불되지 않습니다. 환자 요청으로 치료가 조기 중단되는 경우, 서면 재정 계약서에 따라 완료 비율에 근거한 환불이 계산될 수 있습니다.
- 예약 불이행, 늦은 취소, 응급/수리 내원은 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
- 치료 시작 전 서면 치료 계획서 및 비용 견적을 수령·검토·서명하였습니다.

최종 동의 — HPOA 준수 선언

다음을 선언하고 확인합니다:

- 제안된 교정 치료의 성격, 목적, 예상 이점, 중요한 위험, 가능한 합병증, 합리적 대안(치료하지 않는 선택 포함)에 대해 이해할 수 있는 언어로 설명받았습니다.
- 질문할 충분한 기회를 가졌으며, 모든 질문에 만족스러운 답변을 받았습니다.
- 알레르기, 현재 모든 복용 약물, 관련 건강 상태를 포함한 완전하고 정확한 병력을 제공하였으며, 변경사항이 있을 시 갱신하는 것에 동의합니다.
- 교정 치료의 최종 결과, 편안함, 기간, 안정성에 대한 보장이나 보증이 제공되지 않았음을 이해합니다.
- 치료 성공은 착용, 위생, 음식, 내원 준수에 대한 완전한 협조에 달려 있으며 미협조가 결과를 저해할 수 있음을 이해합니다.
- 재발 방지를 위해 평생 유지장치 착용이 필요함을 이해합니다.
- 치료가 완료되기 전 언제든지 서면으로 동의를 철회할 수 있으며, 이 경우 이미 제공된 서비스에 대한 비용이 청구될 수 있음을 이해합니다.
- 위에 제안된 교정 치료에 자유 의사로 자발적으로 동의합니다.

이 양식은 2026년 4월 1일부터 시행되는 Health Professions & Occupations Act (HPOA)에 따라 작성되었습니다. 서명은 충분한 설명을 받았고 질문할 기회가 있었으며 자유 의사로 동의함을 의미합니다. 언제든지 서면으로 철회

가능합니다.